Expunere de motive

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a prevăzut înfiinţarea în cadrul direcţiilor de sănătate publică a Comisiilor de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis medical pentru a oferi o soluţie alternativă adresării instanţei de judecată persoanelor care solicită constatarea săvârşirii unui act de malpraxis medical. Înfiinţarea acestor comisii doar a creat birocraţie suplimentară, fără ca acestea să îşi îndeplinească rolul de a uşura rezolvarea solicitărilor de despăgubiri pentru acte de malpraxis reclamate. Pentru acest motiv, propunem desfiinţarea acestor comisii.

O persoană (fie pacient sau aparţinător al unui pacient decedat) nemulţumită de un act medical are la dispoziţie 4 remedii procedurale: a) o plângere penală (pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă) - în cazuri extreme, situaţie în care am discuta de eventuala atragere a răspunderii penale; b) o plângere disciplinară adresată corpului profesional din care face parte personalul medical reclamat - caz în care am discuta de eventuale sancţiuni disciplinare (avertisment, vot de blam, suspendarea dreptului de a profesa pe o anumită perioadă etc.), dar fără un beneficiu direct asupra persoanei care reclamă; c) o acţiune civilă în instanţă pentru repararea prejudiciului cauzat, remediul cu capacitatea reală de a se solda cu repararea eventualului prejudiciu şi d) o cerere adresată Comisiei din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică pentru constatarea existenţei sau nu a unui caz de malpraxis medical - procedura a cărei desfiinţare este vizată prin prezenta iniţiativă legislativă.

Potrivit dispoziţiilor art. 683 din Legea nr. 95/2006, Comisia doar stabileşte dacă în cauză a existat sau nu un caz de malpraxis medical, ceea ce presupune pentru persoana care a formulat reclamaţie, în situaţia unei decizii în sensul existenţei unui caz de malpraxis medical, necesitatea formulării unei acţiuni subsecvente în instanţă pentru obţinerea despăgubirilor. Cu alte cuvinte, în loc de a simplifica lucrurile pentru persoanele care doresc atragerea răspunderii civile pentru acte de malpraxis medical, această procedură le complică. Alte neajunsuri care justifică desfiinţarea Comisiei sunt: derularea procedurii în faţa Comisiei **fără a exista contradictorialitate** (spre deosebire de derularea aceleiaşi proceduri direct în faţa instanţei de judecată), **aleatoriul stabilirii cuantumului onorariului datorat expertului/experţilor** care întocmeşte/întocmesc raportul şi inexistenţa pârghiilor de contestare a sa.

Nu se poate identifica niciun avantaj pentru persoanele care formulează aceste reclamaţii în faţa Comisiei, iar nu direct în faţa instanţei. Nici măcar scutirea de la plata taxei judiciare de timbru nu este un argument deoarece cuantumul taxei judiciare de timbru pentru un petit de constatare a săvârşirii unui act de malpraxis medical (echivalentul obiectului de activitate al Comisiei) este în cuantum de 20 de lei (potrivit art. 27 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru), iar plata expertizelor efectuate de către serviciul de medicină legal competent este suportată de către Ministerul Justiţiei (potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) din OG nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală), cât timp plata onorariului expertului/experţilor care efectuează raportul în cadrul procedurii în faţa Comisiei se suportă integral de către persoana care a formulat reclamaţia.

Nu în ultimul rând, potrivit datelor furnizate în mai 2022 de către Ministerul Sănătății, s-au înregistrat în anul 2019 doar 165 de sesizări în fața comisiilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică la nivelul întregii țări (dintre care în 14 s-a constatat existența unui caz de malpraxis și în 2 au existat înțelegeri amiabile), 137 de sesizări în anul 2020 (dintre care în 11 s-a constatat existența unui caz de malpraxis și în 3 au existat înțelegeri amiabile) și 191 în anul 2021 (dintre care în 17 s-a constatat existența unui caz de malpraxis, fără înțelegeri amiabile între părți). Raportat la un număr de 41 de comisii din cadrul direcțiilor de sănătate publică, media cazurilor înregistrate ar fi de 4 per comisie în 2019, 3 cazuri per comisie în 2020 și aproape 5 cazuri per comisie în 2021. Nu se poate justifica existența și funcționalitatea unei comisii în cadrul direcției de sănătate publică pentru 3, 4 sau 5 cazuri pe an.

Inițiativa legislativă nu are impact bugetar. Dimpotrivă, ajută la o mai bună funcționare a direcțiilor de sănătate publică, inclusiv din punct de vedere al gestiunii resurselor umane și financiare.

inițiator: deputat Murariu Oana -USR

Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr.	Deputat/Senator	Grup parlamentar	Semnătura
1	BLAGA DANIEL	USR	
2	TERENTE EUGEN	USR	
3	Badea Mihai Alexandru	USR	
4	BERTEW MONICA-ELENA	USR	
5	NASUI CLAUDIU	USR	
6	RANAIT RADU	USR	
7	ȘTEFAN IULIAN LORINCZ	USR	
8	TUDOR POP	USR	
9	TEHNIȚĂ DRAGOȘ CATALIN	NEAFILIAT	
10	DIANA BUTOIANU	USR	
11	Fălcoi Nicu	USR	
12	GIURGIU ADRIAN	USR	
13	MOLNAR RADU-IULIAN	USR	
14	POLITEANU MIHAI	USR	
15	RADU GEORGE	USR	
16	ANDREI MARIUS MIFTODE	USR	
17	Vodosiu Beniamin	USR	
18.	CAMBERA OTNA	neafiliat	
19	RIZEA CRISTINA-CAMELIA	neafiliat	

Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr.	Deputat/Senator	Grup parlamentar	Semnătura
20	LUPCI ANDREI-RAZVAN	neafiliat	
21	Simina Tulbure	Neafiliat	
22	Ichim Răzvan-Paul	Neafiliat	
23.	Lazăr Ion Marian	USR.	
24.	LAZĂR TEODOR	USR	
25.	CRISTIAN BRIAN	USR	
26	SEILER CRISTIAN GABRIEL	USR	
27	SILVIU ~~STHELEAN~~	USR	
28	STELIAN ION	USR	
29	Dan Barna	USR	
30	OANA SILVIA TOIU	USR	

Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr.	Deputat/Senator	Grup parlamentar	Semnătura
31	[illegible]	PNL	
32	[illegible]	PNL	
33	[illegible]	UDMR	